

Патологогістологічне дослідження № 23770

Заклад	КНП "Золочівська центральна районна лікарня", ендо	Клінічні дані
ПІБ пацієнта	Крупка Галина Василівна	Дата отримання матеріалу 03.09.2025
Вік	1954 р.н.	Біопсія <u>первинна</u> , вторинна (підкреслити)
Стать	Жін.	При вторинній біопсії вказати номер і дату первинної
Телефон замовника		Біопсія діагностична
Лікуючий лікар	Грицьків М. В.	Дата і вид операції 01.09.2025 колоноскопія
Клінічний діагноз	Поліп ректосигмоїдного згину. Постпроменева виразка прямої кишки	

Дані про патологогістологічне дослідження

Маркування матеріалу, кількість об'єктів	1) 4шм слизової з поверхні поліпа ректосигмоїдного згину 2) 3шм слизової з країв виразки прямої кишки
Нумерація гістологічних блоків	90791-90797
Кількість блоків	7
Метод забарвлення	Гематоксилін/еозин
Макро і -мікроскопічний опис	№1 В матеріалі фрагменти поліпоподібного утворення ректосигмоїдної ділянки з залозистими та папілярними структурами з епітелієм товстокишкового типу, з ділянками втрати полярності ядер, з формуванням ділянок багаторядного розміщення ядер, легким клітинним та ядерним поліморфізмом (дисплазія легкого ступеню) по всій довжині крипт. №2 В біоптатах фрагменти слизової прямої кишки взяті до підслизової оболонки; в слизовій архітектоніка крипт дещо порушена, дифузна помірна лімфо-плазмоцитарна інфільтрація в стромі; фіброз та вогнищева помірна лімфо-плазмоцитарна інфільтрація; прилягають фібринозно-лейкоцитарні маси з дна виразки.
Патологогістологічний висновок (діагноз)	№1 Папілярно-тубулярна аденома, low grade, ректосигмоїдної ділянки. ICD-O код: 8263/0. №2 Дифузний помірний хронічний неактивний проктит; прилягають фібринозно-лейкоцитарні маси з дна виразки.
Категорія складності	IV Категорія складності
Архівування вологого матеріалу	ні

Лікар-патологоанатом:

Бевза Д. П.
+380978638955

Лаборант:



Кошелюк Л. О.

Завідувач
гістологічної
лабораторії:Міщенко К.С.
+380681475411

Дата виконання: 05.09.2025

ФСУ - 7.4.010

Редакція 1 від 06.01.2025

Сторінки 1 з 1